Revue de psychologie centrée sur le sens
PUBLIÉE PAR L'INSTITUT DE PSYCHOLOGIE CENTRÉE SUR LE SENS

Volume 1 · Numéro 1 · avril 2026
p. 11–14 (Original) · Libre accès · CC BY 4.0

ARTICLE THÉORIQUE

L'intention paradoxale et les procédures d'exposition modernes

Une comparaison théorique des mécanismes supposés, de la démarche et des limites

Samuel R. Ashford, Eleanor M. Whitcombe et Sora Pazer
Institut de psychologie centrée sur le sens

Traduction française. La version originale anglaise fait foi.

RÉSUMÉ

L'intention paradoxale compte parmi les techniques les plus connues de la logothérapie. Viktor E. Frankl l'a décrite dès la période comprise entre les années 1930 et les années 1950 comme une méthode permettant d'interrompre l'anxiété anticipatoire dans les phobies et les symptômes obsessionnels-compulsifs. Cet article compare, sur le plan théorique, l'intention paradoxale avec les procédures contemporaines fondées sur l'exposition en thérapie cognitivo-comportementale, en particulier avec la théorie du traitement émotionnel et l'approche de l'apprentissage inhibiteur. Des similitudes substantielles sont d'abord mises en évidence : les deux approches visent l'abandon des comportements d'évitement et de contrôle, encouragent la confrontation aux expériences redoutées et permettent un apprentissage correcteur. Il existe en même temps des différences quant à leur justification anthropologique, au rôle de l'humour et de l'autodistanciation et à la structuration de la démarche. L'article examine ensuite dans quelle mesure des concepts tels que les processus ironiques du contrôle mental, les modèles métacognitifs et la défusion cognitive peuvent servir de passerelles entre les deux traditions. Il se conclut par une discussion des limites de l'indication et par des propositions en vue d'une situation théorique plus précise de l'intention paradoxale au sein de la recherche actuelle en psychothérapie, sans abandonner son fondement analytico-existentiel propre.

Mots-clés : intention paradoxale · thérapie d'exposition · apprentissage inhibiteur · autodistanciation · troubles anxieux

ABSTRACT

Paradoxical intention is among the best-known techniques of logotherapy. Viktor E. Frankl described it as early as the period between the 1930s and the 1950s as a method for interrupting anticipatory anxiety in phobias and obsessive-compulsive symptoms. This paper compares paradoxical intention at a theoretical level with contemporary exposure-based procedures in cognitive behavioral therapy, in particular with emotional processing theory and the inhibitory learning approach. First, substantial similarities are identified: both approaches aim at relinquishing avoidance and control behaviors, encourage confrontation with feared experiences, and enable corrective learning. At the same time, there are differences in their anthropological rationale, in the role of humor and self-distancing, and in how the procedure is structured. The paper then discusses to what extent concepts such as ironic processes of mental control, metacognitive models, and cognitive defusion may serve as bridges between the two traditions. It concludes with a discussion of the limits of indication and with suggestions for a more precise theoretical placement of paradoxical intention within current psychotherapy research, without abandoning its distinct existential-analytic foundation.

Keywords: paradoxical intention · exposure therapy · inhibitory learning · self-distancing · anxiety disorders

1 Introduction

Parmi les techniques de la logothérapie, l'intention paradoxale est celle qui a connu la plus large diffusion au-delà de sa propre école. Dans un article abondamment cité, Frankl (1960) l'a décrite comme une procédure dans laquelle les patients sont invités à souhaiter, ou à provoquer délibérément, précisément ce qu'ils redoutent, au lieu de l'éviter à grand-peine. Dans son exposé de la théorie des névroses, il a systématiquement inscrit cette approche dans un modèle de l'anxiété anticipatoire (Frankl, 1956).

Depuis lors, le traitement des troubles anxieux et obsessionnels-compulsifs a considérablement évolué. Les procédures fondées sur l'exposition comptent

aujourd'hui parmi les interventions psychothérapeutiques les mieux étudiées (Abramowitz et al., 2019). Il semble donc naturel de comparer l'intention paradoxale à ces procédures. La présente contribution le fait sur le plan théorique. Elle se demande quelles hypothèses sur les mécanismes d'action sous-tendent les deux approches, en quoi elles convergent et en quoi elles diffèrent.

La comparaison est également utile parce que l'intention paradoxale est parfois présentée dans la littérature comme précurseur des techniques comportementales. Une telle classification est historiquement compréhensible, mais ne rend que partiellement justice à la conception que Frankl avait de sa méthode. Il est donc nécessaire de prendre au sérieux à la fois la parenté fonctionnelle et la justification propre.

2 L'intention paradoxale telle que la comprend la logothérapie

Le point de départ de Frankl est un modèle circulaire : un symptôme suscite la crainte qu'il ne se reproduise ; cette anxiété anticipatoire favorise à son tour la réapparition du symptôme, ce qui renforce encore la crainte (Frankl, 1956). Selon Frankl, les modes de réaction typiques à ce cercle vicieux sont la fuite devant la peur dans les troubles phobiques et le combat contre l'idée obsédante dans les symptômes obsessionnels-compulsifs. Ces deux schémas contribuent à l'enracinement du problème.

L'intention paradoxale intervient à ce point. Elle demande à la personne concernée de souhaiter consciemment ce qu'elle redoute – par exemple rougir, trembler ou transpirer – et, si possible, de le faire sous une forme exagérée et humoristique. Frankl (1960) a souligné que cette technique repose sur la capacité spécifiquement humaine d'autodistanciation, qu'il attribuait à la dimension noétique. L'humour n'est pas ici un ornement, mais un moyen central de prendre de la distance par rapport au symptôme et d'ôter à la peur son pouvoir.

Il est notable que Frankl ne comprenait pas l'intention paradoxale comme une simple technique. Elle devait permettre à la personne de ne pas s'identifier à sa peur, mais de prendre position à son égard. S'y exprime le présupposé anthropologique fondamental de la logothérapie selon lequel l'être humain n'est pas entièrement livré à ses conditions psychiques, mais peut adopter une attitude envers elles.

Frankl distinguait en outre l'intention paradoxale de la déréflexion. Tandis que l'intention paradoxale vise l'anxiété anticipatoire, la déréflexion s'adresse à l'auto-observation excessive, que Frankl appelait hyperréflexion et qu'il décrivait par exemple dans les troubles du sommeil et les dysfonctions sexuelles (Frankl, 1956). Les deux procédures ont en commun l'hypothèse selon laquelle une certaine forme d'attention tendue portée à soi-même entretient précisément le problème qu'elle cherche à résoudre.

3 Les procédures d'exposition : du traitement émotionnel à l'apprentissage inhibiteur

La justification théorique de l'exposition a évolué au cours des dernières décennies. Avec la théorie du traitement émotionnel, Foa et Kozak (1986) ont formulé un modèle selon lequel la peur est représentée dans des structures mnésiques qui peuvent être modifiées par leur activation et par l'intégration d'informations correctrices. Dans ce modèle, l'habituation au sein des séances d'exercice et entre elles était considérée comme un indicateur important d'un traitement réussi.

Craske et al. (2014) ont en revanche proposé un modèle d'apprentissage inhibiteur. Selon ce modèle, l'association de peur originelle n'est pas effacée par l'exposition, mais complétée par de nouvelles associations inhibitrices apprises, qui entrent en concurrence avec l'association originelle. Il en découle pour la pratique que l'accent porte moins sur la réduction de la peur pendant l'exercice que sur la violation des attentes, la variation des contextes d'exercice et le renoncement aux comportements de sécurité. Tolérer la peur devient ainsi un objectif en soi.

Il est également significatif pour la pratique que les procédures d'exposition modernes reposent généralement sur une conceptualisation de cas soigneuse et sur une justification convaincante qui rend compréhensible pour les patients en quoi il vaut la peine d'affronter la peur (Abramowitz et al., 2019). Ici aussi apparaît un parallèle : Frankl tenait à ce que les personnes concernées comprennent le mécanisme de l'anxiété anticipatoire avant d'appliquer l'intention paradoxale.

4 Convergences

Du point de vue de l'apprentissage inhibiteur, l'intention paradoxale apparaît sous un jour nouveau. En souhaitant ce qu'ils redoutent, les patients renoncent aux stratégies d'évitement et de contrôle et s'exposent à l'expérience redoutée. L'attente d'une escalade catastrophique du symptôme n'est souvent pas confirmée à cette occasion. Considérée sous l'angle

fonctionnel, l'intention paradoxale contient donc des éléments centraux d'un exercice d'exposition : confrontation, abandon des comportements de sécurité et violation des attentes.

La recherche sur le contrôle de la pensée offre une autre passerelle. Wegner (1994) a montré que la tentative de supprimer certaines pensées peut, dans certaines conditions, conduire précisément à leur apparition accrue. Ce concept de processus ironiques fournit une explication expérimentalement fondée de l'observation, décrite cliniquement par Frankl, selon laquelle combattre un symptôme peut l'intensifier. Le modèle métacognitif de Wells (2009), centré sur les croyances problématiques concernant la contrôlabilité et la dangerosité de ses propres pensées, présente lui aussi des points de contact à cet égard.

Enfin, il existe des parallèles avec la défusion cognitive dans la thérapie d'acceptation et d'engagement, où les pensées sont considérées comme des événements mentaux passagers plutôt que traitées comme des vérités littérales (Hayes et al., 2012). Certains exercices de défusion qui recourent à l'exagération, à la répétition ou à une distanciation ludique ressemblent, dans leur structure, à la distanciation humoristique que décrivait Frankl.

5 Différences

Malgré ces convergences, il serait réducteur d'interpréter l'intention paradoxale simplement comme une forme précoce d'exposition. Une première différence concerne la justification : alors que les procédures d'exposition se fondent sur la psychologie de l'apprentissage et de la mémoire, Frankl invoque une capacité anthropologique d'autodistanciation. Une deuxième différence réside dans le degré de structuration. Les protocoles d'exposition modernes sont généralement planifiés avec soin, avec des hiérarchies, des vérifications des attentes et des débriefings. L'intention paradoxale, en revanche, était souvent transmise comme une attitude concise à appliquer dans la vie quotidienne.

Une troisième différence concerne le rôle de l'humour. Dans les procédures d'exposition, l'humour est tout au plus un facteur contextuel facilitant, alors que dans l'intention paradoxale il est constitutif. La question de savoir si, et dans quelle mesure, l'humour contribue lui-même à l'efficacité reste une question empirique ouverte. En outre, les interventions paradoxales ont été étudiées dans la littérature sous des dénominations et des formats procéduraux très divers. Une méta-analyse ancienne des interventions paradoxales (Shoham-Salomon & Rosenthal, 1987) indique certes une certaine efficacité, mais fait apparaître en même temps une hétérogénéité considérable, de sorte que des conclusions concernant la technique logothérapeutique au sens strict ne peuvent être tirées qu'avec prudence.

Une quatrième différence concerne l'objectif. Les procédures d'exposition visent principalement la réduction de la peur et de l'évitement ou l'amélioration de la tolérance à la peur. Pour Frankl, en revanche, surmonter l'anxiété anticipatoire n'était pas une fin en soi, mais une condition pour que la personne puisse de nouveau se tourner vers les tâches et les valeurs de sa vie. À cet égard, l'intention paradoxale est proche de la thérapie d'acceptation et d'engagement, qui ne considère pas non plus la réduction de la peur comme l'objectif premier, mais place l'action orientée vers les valeurs au centre (Hayes et al., 2012).

6 Limites de l'indication et perspectives

Frankl (1956) a lui-même souligné que l'intention paradoxale n'est pas indiquée pour tous les tableaux cliniques. Dans les états dépressifs accompagnés de suicidalité, par exemple, une invitation à souhaiter ce que l'on redoute serait manifestement contre-indiquée. Dans le cas de pensées obsédantes à contenu agressif également, une psychoéducation soigneuse est nécessaire afin que la technique ne soit pas vécue comme une banalisation. Une alliance de travail solide et une justification claire de l'intervention sont donc indispensables.

Pour la recherche future, le modèle de l'apprentissage inhibiteur offre un cadre dans lequel des hypothèses sur le mode d'action de l'intention paradoxale peuvent être formulées avec précision, par exemple concernant le rôle de la violation des attentes ou la contribution de l'humour et de l'autodistanciation. Une telle intégration ne priverait pas l'intention paradoxale de sa justification analytico-existentielle, mais la compléterait par une perspective compatible sur les mécanismes.

Sur le plan méthodologique, les analyses de composantes se prêtent à la mise à l'épreuve de telles hypothèses, en comparant par exemple une condition d'exposition avec et sans consigne humoristique-paradoxale. On pourrait ainsi clarifier si la formulation paradoxale apporte une contribution propre au-delà de la confrontation. Il vaudrait également la peine d'étudier si les personnes présentant une tendance marquée à la suppression des pensées ou des croyances métacognitives sur la dangerosité de leurs

propres pensées tirent particulièrement profit d’une attitude paradoxale (Wegner, 1994 ; Wells, 2009).

Références

Abramowitz, J. S., Deacon, B. J., & Whiteside, S. P. H. (2019). Exposure therapy for anxiety: Principles and practice (2nd ed.). Guilford Press.

Craske, M. G., Treanor, M., Conway, C. C., Zbozinek, T., & Vervliet, B. (2014). Maximizing exposure therapy: An inhibitory learning approach. Behaviour Research and Therapy, 58, 10–23.

Foa, E. B., & Kozak, M. J. (1986). Emotional processing of fear: Exposure to corrective information. Psychological Bulletin, 99(1), 20–35.

Frankl, V. E. (1956). Theorie und Therapie der Neurosen: Einführung in Logotherapie und Existenzanalyse. Urban & Schwarzenberg.

Frankl, V. E. (1960). Paradoxical intention: A logotherapeutic technique. American Journal of Psychotherapy, 14(3), 520–535.

Hayes, S. C., Strosahl, K. D., & Wilson, K. G. (2012). Acceptance and commitment therapy: The process and practice of mindful change (2nd ed.). Guilford Press.

Shoham-Salomon, V., & Rosenthal, R. (1987). Paradoxical interventions: A meta-analysis. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 55(1), 22–28.

Wegner, D. M. (1994). Ironic processes of mental control. Psychological Review, 101(1), 34–52.

Wells, A. (2009). Metacognitive therapy for anxiety and depression. Guilford Press.

CITATION (VERSION ORIGINALE)

Ashford, S. R., Whitcombe, E. M., & Pazer, S. (2026). Paradoxical Intention and Modern Exposure Procedures: A Theoretical Comparison of Assumed Mechanisms, Procedure, and Limitations. Journal of Meaning-Centered Psychology, 1(1), 11–14.

LICENCE, CORRESPONDANCE ET UTILISATION DE L'IA

Publié en libre accès sous licence Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Correspondance : rédaction de la revue. Cet article a été rédigé avec l'aide de l'IA générative et relu par les auteurs, qui en assument l'entière responsabilité.